## 内科+外科 急性胰腺炎 ★★★（1~4题）

病因：胆石症（我国最常见）、饮酒、ERCP、房颤、糖皮质激素等
暴饮暴食突发上腹偏左痛、向左肩及腰背放射，呕吐不减轻、弯腰抱膝减轻
血淀粉酶 / 脂肪酶↑（重症者可↑、正常、↓）
（内 2008、2010、2012、2022，外 2008、2009、2014、2015、2016、2021、2023、2024、2026）

| | 水肿型（多见） | 出血坏死型 |
|---|---|---|
| **渗出** | 无或轻度局限<br>腹膜刺激征 | 可有明显广泛腹膜刺激征<br>明显腹胀、肠鸣音↓↓、移动性浊音 |
| **出血** | 无 | 血性腹水、G-T 征或 Cullen 征（脐周，外 2024） |
| **发热** | 无或轻 | 持续 |
| **血 WBC ↑** | 无或轻 | 明显 |
| **并发胰腺感染** | | T ＞ 38.5°C、血 WBC ＞ 16、ANC 或 WON 气泡征 |
| 全身并发症 | 无 | 休克、SIRS、ARDS、AKI 等<br>ACS：≥ 20 诊断、≥ 25 手术（外 2013、2016、2017） |

**上腹触及囊性包块**

- **假性囊肿：病程 1 个月左右（纤维增生包裹均匀液性密度）＞ 6cm 等保守治疗待 6~8 周→引流术（如囊肿空肠 R-Y 吻合等内引流）（外 2009、2010、2011、2014）**
- **包裹性坏死：纤维增生包裹不均匀混杂密度**

**检查**

- **诊断首选：血淀粉酶（内 2008、2010、2011、2022、2023 外 2022）**
  - 与诊断准确率有关、与严重程度无关
  - 血淀粉酶升高最早、持续最短（血脂肪酶适合发病 1 周血淀粉酶已恢复者）
- **与严重程度有关（外 2018）**
  - 诊断重症胰腺炎最佳：腹水淀粉酶（内 2012）
  - 血钙常＜ 2、血糖（后期）常＞ 11.1、血 WBC ＞ 16 等（内 2024）
  - CT
    - 诊断最佳影像学（外 2009、2016）
    - 明确坏死程度、并发症、决定手术方案最佳（外 2015）
    - 胰腺增大、边界不清、胰周积液
      胰腺不规则液性低密度区（胰腺坏死）、不均匀强化